リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月14日（水）
第34号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 回復期リハ・多剤併用 ▸ 制度・就労支援 ▸ 嚥下・脱水 ▸ 短信 8本

■ 回復期リハ・多剤併用

回復期の脳血管疾患4.5万人、多剤でFIM効率が低下　利得は差なし

入院中に新たに6剤以上になった群で最も低下（日本のレセプト研究）

日本のレセプトデータベース（JMDC）を使い、脳血管疾患で回復期リハ病棟に入院した65歳以上44,980人を調べた後ろ向き研究が、Drugs - Real World Outcomesに出ました。6剤以上を多剤併用とし、入院時と退院時の状態で4群に分けて、FIM利得（主要評価）とFIM効率を比べています。

入院から退院まで多剤併用が続いた人は48.9%、入院中に新たに多剤になった人は14.8%でした。患者背景や併存疾患、病床規模で調整すると、FIM利得は多剤併用の有無で有意な差がありません。一方、FIM効率は多剤のある3群で低く、最も下がったのは新たに多剤になった群（B=-0.114）、次が続いた群（B=-0.069）でした。

著者は、FIM効率の差は在院日数の違いを一部反映している可能性があり、薬の負担の変化と回復の因果関係は示せないとしています。「減薬すればFIMが伸びる」とはまだ言えませんが、増えた薬を見直すきっかけになります。



因果は未確定。入院中に増えた薬を見直す合図に。

出典 Drugs Real World Outcomes ↗

数字で見る

44,980人
回復期病棟に入院した65歳以上の脳血管疾患

48.9%
入院から退院まで多剤併用が続いた割合

-0.114
新たに多剤になった群のFIM効率（回帰係数B）

■ 制度・就労支援

脳卒中関係8団体、両立支援の加算にPT・OT・ST追加を要望

日本脳卒中学会や日本理学療法士協会など8団体が10月2日、厚生労働大臣に要望書を提出しました。両立支援指導料の算定期間（6か月）の延長、相談支援加算の対象へのPT・OT・ST追加、標準的算定日数の除外対象に「脳卒中後の就労支援」を加える、の3項目です。

11府県237施設の調査では、復職候補2,932人に就労支援リハを行っても、指導料を算定できたのはPT0.23%・OT0.13%・ST0.79%でした。退院後12か月以上続けられたのは1.5%・1.0%・4.4%です。実現には中医協の議論が必要です。



出典 日本理学療法士協会（要望書） ↗

■ 嚥下・脱水

脱水と嚥下障害が重なると院内死亡12.1%　ドイツ134万入院

ドイツの急性期老年科の登録（GEMIDAS Pro、2006～2024年）で、65歳以上の入院1,343,561件を分析しました（Eur Geriatr Med）。脱水は13.2%に記録され、院内死亡は脱水ありで5.8%、なしで2.6%でした。

死亡は、どちらもなし2.2%、脱水のみ4.7%、嚥下障害のみ8.6%、両方で12.1%。嚥下障害で調整しても脱水の調整オッズ比は1.35（95%CI 1.32～1.38）でした。診断名から拾った観察研究で、因果は言えません。



出典 Eur Geriatr Med ↗

短信

〈脳卒中〉 **発症3か月のQOL、心理面は1か月で頭打ち**
初発111人の前向き研究。身体QOLは歩行、精神QOLは抑うつと独立に関連（β-0.692）。 出典 NeuroRehabilitation ↗

〈無視〉 **プリズム順応、左右の半側空間無視に効果**
3施設48人のRCT、2週10回。BIT・CBS・MBIの改善幅が偽眼鏡群を上回り、左無視でより大きい。
出典 Neurorehabil Neural Repair ↗

〈ST〉 **没入型VRの呼称自主訓練、呼称で上回る**
慢性期失語102人のRCT、8週。呼称（p=0.001）と楽しさで通常訓練を上回る。単施設。 出典 Clin Rehabil ↗

〈退院支援〉 **継続ケア介入、家族を含むものは少数**
RCT80研究65介入のスコーピングレビュー。多くは本人のみ対象で急性期から在宅への移行が中心。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈高齢者〉 **食欲不振で移動能力の低下が1.44倍**
米国70～79歳3,073人を最長6年追跡。炎症マーカー高値も独立に関連し、重なると低下が早い。 出典 J Am Geriatr Soc ↗

〈呼吸〉 **COPDの在宅呼吸リハ、アプリで遠隔管理**
20人の実現可能性研究、8週。19人が完遂し満足度も高い。対照群はなく効果は未検証。 出典 Arch Phys Med Rehabil ↗

〈制度〉 **介護17団体、報酬の大幅引き上げを要望**
PT・OT・ST協会も連名で10月6日に官房長官へ。緊急調査1,445件・8,219事業所分を添付。 出典 POST ↗

〈医療AI〉 **カメラ型AIのBESS採点、目視より誤差小**
80人の横断研究。基準とのICC0.989、平均絶対誤差0.787回で、現場の目視（2.212回）より小さい。
出典 Sports Med Open ↗